

Twój pełny raport PEWA™

Typ: Przyjaciel + Entuzjasta (PE)

Supermoc zespołu — łączysz ludzi sercem, ciepło prowadzisz

Sekcja 1 — Kim jesteś (profil rozszerzony)

Twój dominujący archetyp to **Przyjaciel** — empatyczny słuchacz, dla którego relacja jest fundamentem każdej decyzji. Pacjent w Twoim gabinecie nie czuje się “przypadkiem 13:30”, tylko człowiekiem, którego rozumiesz. Zanim podejmiesz decyzję kliniczną, instynktownie sprawdzasz: co ta osoba czuje, czego się boi, czy mi ufa. Lojalność, ciepło i poczucie bezpieczeństwa są walutą, którą wymieniasz z otoczeniem.

Drugi archetyp w Twojej sygnaturze to **Entuzjasta** — emocjonalny mówca, który nie tylko czuje, ale potrafi tę emocję wyrazić, podzielić się nią, zarazić nią innych. To on sprawia, że Twoje słuchanie nie jest pasywne — odpowiadasz uśmiechem, gestem, opowieścią z własnego życia, naturalnym entuzjazmem. Pacjent wychodzi nie tylko zrozumiany — wychodzi z energią, której nie miał wchodząc.

Razem te dwa archetypy tworzą profil, który w 14 latach moich badań z zespołami medycznymi okazał się jedną z najbardziej **lojalnych grup pacjentów**. Twoi pacjenci wracają, polecają Cię rodzinie, wybaczą drobne potknięcia organizacyjne — bo Ty dałeś im coś, czego nie da się zmierzyć w protokole klinicznym: poczucie, że ktoś naprawdę był tam dla nich.

Twoja supermoc w jednym zdaniu: *Tworzysz przestrzeń, w której pacjent czuje, że jest u siebie — a kolega z zespołu, że ma na kim się oprzeć.*

Co Cię energizuje: rozmowy w 4 oczy, opieka długoterminowa, zespołowe burze mózgów, sytuacje wymagające ciepła, pacjent który wreszcie się otworzył, pochwała od pacjenta po zabiegu.

Co Cię wyczerpuje: twarde negocjacje, długie cisze, konflikty w zespole, decyzje wymagające ucięcia relacji, krytyka publiczna, sztywne procedury bez przestrzeni na ludzki kontakt.

Sekcja 2 — Twoja sygnatura komunikacyjna

Sposób w jaki mówisz jest tak charakterystyczny, że można Cię rozpoznać z dwóch zdań przez ścianę. Ciepły ton, dużo pytań otwartych, naturalne łączenie

własnego doświadczenia z sytuacją pacjenta, optymistyczne ramowanie nawet trudnych spraw.

5 zdań, które wypowiadasz częściej niż inni

1. *“Rozumiem co Pan/Pani teraz przeżywa.”*
2. *“Razem się tym zajmiemy.”*
3. *“Spokojnie, mamy czas.”*
4. *“To naprawdę dobre pytanie.”*
5. *“Wierzę, że da się to przejść.”*

5 zdań, które rzadko wypowiadasz

1. *“To nie moja sprawa.”*
2. *“Niech Pan/Pani się sam(a) z tym pogodzi.”*
3. *“Mamy procedurę, nie ma o czym dyskutować.”*
4. *“Następny.”*
5. *“Brak czasu na rozmowy — proszę do recepcji.”*

Twoje narzędzia niewerbalne

- **Kontakt wzrokowy** — utrzymujesz go dłużej niż średnia, intuicyjnie regulujesz napięcie do komfortu pacjenta.
- **Otwarte ciało** — ramiona nieskrzyżowane, ciało zwrócone w stronę rozmówcy, lekkie przechylenie głowy.
- **Dotyk neutralny** — krótko, jednorazowo: ramię, dłoń (gdy uznasz to za stosowne i akceptowane).
- **Pauza po pytaniu** — pozwalasz pacjentowi się zastanowić, nie wypełniasz ciszy.

Jak najlepiej do Ciebie trafia inny lekarz/szef

- Krótka informacja zwrotna w cztery oczy (nie publicznie).
- Pochwała emocjonalna (*“Dziękuję, że to zauważyłeś”*) działa lepiej niż finansowa.
- Wyjaśnienie kontekstu zanim wydanie polecenia.
- Pytanie o Twoje zdanie zanim zostanie podjęta decyzja zespołowa.

Sekcja 3 — Mocne strony rozszerzone

Twoich talentów jest więcej niż 3 wymienione w mailu — oto pełna mapa.

1. Magnes na zaufanie

Pacjent zwierza się Tobie z rzeczy, których nie powiedział żadnemu lekarzowi. **Użyj tego:** w pierwszej rozmowie z nowym pacjentem zostaw 2 minuty na „luźną” rozmowę zanim przejdziesz do badania. Wyłapiesz informacje, których nie zdobędziesz przez wywiad strukturalny.

2. Optymistyczne ramowanie

Pokazujesz nadzieję nawet w trudnych diagnozach, bez bagatelizowania. **Użyj tego:** przy informowaniu o trudnym leczeniu zacznij od *“Da się to przejść — chcę powiedzieć Ci jak”*, zamiast od listy ryzyk.

3. Energia jako zaraza

Twoje wejście do gabinetu zmienia atmosferę. Pacjent, który czekał spięty, oddycha po 30 sekundach z Tobą. **Użyj tego:** poranny obchód zacznij od najbardziej spiętego pacjenta — Ty masz najwięcej energii, on potrzebuje jej najbardziej.

4. Czytanie emocji w mig

Rozpoznajesz w 5 sekund, czy pacjent się boi, ukrywa coś, czy próbuje się przypodobać. **Użyj tego:** zanim zapytasz „co Pana boli“, zapytaj „co Pan czuje w związku z tą wizytą”. To otworzy temat, którego Pan sam by nie poruszył.

5. Naturalność w small-talk

Inni muszą się uczyć rozmów luźnych — Ty to robisz instynktownie. **Użyj tego:** wykorzystaj recepcję jako przedłużenie gabinetu. Kilka słów do recepcjonistki o pacjencie (*“on dziś przyszedł zdenerwowany, daj mu wodę”*) robi cuda dla DOP.

6. Lojalność jako kotwica

Twój zespół ma do Ciebie zaufanie. Wiedzą, że ich nie zostawisz w trudnej chwili. **Użyj tego:** w trudnym momencie firmowym (zmiana, konflikt, kryzys) bądź pierwszą osobą, która się odezwie do zespołu. Twoja stabilność emocjonalna ich uspokoi.

7. Otwartość na nowe pomysły

Pacjent, kolega, młody asystent — każdy może Ci coś podpowiedzieć i wysłuchasz. **Użyj tego:** raz w miesiącu zapytaj recepcjonistkę: *“co mogłbym zmienić, żeby pacjenci wychodzili szczęśliwi”*. Dostaniesz konkrety.

8. Naturalny PR

Pacjenci polecają Cię rodzinie — i to nie dlatego, że proszą. Po prostu chcą o Tobie mówić. **Użyj tego:** nie udawaj że to nie istnieje. Subtelnie wprowadzaj: *“jak Pani córka też kiedyś będzie potrzebować...”*

9. Cierpliwość w przewlekłych przypadkach

Tam, gdzie inny lekarz odpuszcza po trzeciej wizycie, Ty nie odpuszczasz po dziesiątej. **Użyj tego:** prowadź dłuższe leczenie (cukrzyca, choroby autoimmunologiczne) — to Twoja domena.

10. Tworzenie poczucia bezpieczeństwa

Pacjent czuje że *jest u siebie*. **Użyj tego:** drobne detale (jego ulubiona herbata, pytanie o psa którego wspominał, zapamiętanie imienia dziecka) zwracają inwestycję dziesięciokrotnie w lojalności.

Sekcja 4 — Naturalne wyzwania + pierwsza pomoc

Twoja kombinacja PE oznacza, że największe trudności pojawiają się tam, gdzie trzeba przeciąć relację, zająć twarde stanowisko, lub stłumić własną reakcję emocjonalną. Oto 9 typowych sytuacji z 14 lat praktyki z zespołami medycznymi.

1. Pacjent wymagający, agresywny lub manipulujący emocjonalnie

Sygnal wczesny: czujesz ucisk w gardle, chcesz znaleźć kompromis za wszelką cenę, automatycznie zaczynasz tłumaczyć i przeproszać.

Pierwsza pomoc w 60 sek: - Trzy oddechy: wdech 4 sek, zatrzymanie 4 sek, wydech 6 sek. - Wypowiedz na głos: *“Rozumiem że jest Pan/Pani sfrustrowany — i jednocześnie potrzebujemy zająć się sprawą kliniczną. Zrobimy to teraz.”* - Spuść wzrok na 2 sekundy (sygnal ciała: oddzielam emocje).

Plan długofalowy: - Sesja z superwizorem / coachem 1× / kwartał na takie sytuacje. - Ćwicz “miłe nie” — odmów 1 prośby tygodniowo, najmniejsze na początek. - Wprowadź regułę: nigdy nie podejmuję ważnej decyzji w pierwszych 60 sekundach kontaktu z pacjentem.

2. Konflikt w zespole

Sygnal wczesny: stajesz się mediatorem zanim Cię poproszą; gotujesz się wewnątrz, ale na zewnątrz uśmiechasz.

Pierwsza pomoc: zatrzymaj się i zapytaj *“Czy chcesz, żebym to mediowała, czy chcesz, żebym powiedziała co myślę?”*. Nie wchodź w pośrednictwo automatycznie.

Plan długofalowy: ucz się “jasnej życzliwości” (Brené Brown) — możesz być ciepły i jednocześnie powiedzieć trudne zdanie.

3. Decyzja finansowa pod presją

Sygnal wczesny: widzisz koszt zaniedbania ludzkiego, ignorujesz biznesowy.

Pierwsza pomoc: odłóż decyzję o 24 godziny. Powiedz: *“Dam Państwu odpowiedź jutro do południa”*.

Plan długofalowy: raz na kwartał spotkanie 1:1 z księgową/zarządcą — sprawdź czy Twoje “ciepłe decyzje” mają finansową bazę.

4. Krytyka publiczna (recenzja, post, opinia w internecie)

Sygnal wczesny: rumieniec, chęć natychmiastowego napisania długiej odpowiedzi, branie do siebie wszystkiego.

Pierwsza pomoc: zasada 24 godzin — nie odpowiadaj dziś. Napisz odpowiedź do szuflady, jutro przeczytaj na zimno.

Plan długofalowy: poproś kogoś z zespołu (najlepiej typ WA) o monitoring opinii i pierwszą filtrację.

5. Konieczność zdyscyplinowania kolegi/asystenta

Sygnal wczesny: odkładasz rozmowę dni, tygodnie; wpadasz w okrzęzne podpowiedzi licząc że zrozumie sam.

Pierwsza pomoc: wprowadź formułę *“Doceniam Cię i jednocześnie muszę Ci coś powiedzieć”*. Zaczynij od *“doceniam”* prawdziwie — koniec końców jesteś Przyjacielem, to autentyczne.

Plan długofalowy: raz w miesiącu robisz 1:1 z każdym z zespołu — feedback NIE może wybuchnąć dopiero na koniec.

6. Pacjent który zostaje w gabinecie dłużej niż wizyta

Sygnal wczesny: spojrzenie na zegar, gniew który tłumisz, frustracja na kolejne wizyty które są opóźnione.

Pierwsza pomoc: *“Dziękuję Pani za rozmowę, dziś mam pełen kalendarz. Umówmy się na dłuższą wizytę za 3 dni — zarezerwuję dla nas 30 minut.”*

Plan długofalowy: wprowadź “wizyty długie” 1× / tydzień (45 min zamiast 15) — dla pacjentów którzy potrzebują czasu. Tym automatyzujesz przekierowanie.

7. Praca po godzinach “bo trzeba pomóc”

Sygnal wczesny: zostajesz „tylko 15 min więcej” — 3× w tygodniu.

Pierwsza pomoc: ustaw alarm na 17:30 z napisem *“Czego nie zrobię dziś, zrobię jutro lepiej”*.

Plan długofalowy: kolega z zespołu (preferencyjnie WA) niech ma uprawnienia do wezwania Cię do telefonu o 17:35 z fikcyjnym powodem. Ćwiczysz wychodzenie.

8. Konfrontacja z kolegą o twardszym podejściu (typ W)

Sygnal wczesny: w głowie układasz długie wyjaśnienia, dlaczego to co czuję jest ważne — i nie wierzysz że zostanie zrozumiane.

Pierwsza pomoc: zacznij od jego języka. *“Mam dane: 3 pacjentów wybrało innego lekarza w tym miesiącu, bo poczuli się przyśpieszani.”* — fakty, potem emocje.

Plan długofalowy: ucz się prezentować swoje obserwacje w liczbach. Twoja intuicja jest cenna — ale w rozmowie z W musisz ją “ubrać” w fakt.

9. Mówienie pacjentowi że nie możesz dłużej go prowadzić (przekierowanie)

Sygnal wczesny: miesiącami odkładasz, wymyślasz dlaczego “jeszcze trochę da się”.

Pierwsza pomoc: *“Pan/Pani jest dla mnie ważny, i właśnie dlatego mówię — będzie Pan/Pani miał lepsze rezultaty u doktora X. Tu jest nazwisko, tu telefon.”* Twoja ciepłość jest wzmocnieniem profesjonalnej decyzji, nie jej przeciwieństwem.

Plan długofalowy: miesięczna review: 5 najtrudniejszych przypadków — czy któryś powinien być przekierowany?

Sekcja 5 — Twoje duety w zespole

Każdy z 4 archetypów PEWA inaczej współpracuje z Tobą. Oto mapa.

Z drugim Przyjacielem (P)

Plus: rozumiecie się bez słów, atmosfera ciepła, lojalność totalna. **Ryzyko:** brak twardych decyzji, gotujecie się w empatii, niczego nie domykacie. **Co robić:** zaprosicie trzeciego — W lub A — żeby dał strukturę.

Z drugim PE

Plus: super energia, świetne relacje z pacjentami, dobry PR praktyki. **Ryzyko:** chaos organizacyjny, brak konsekwencji, każdy mówi “tak” wszystkim. **Co robić:** zatrudnijcie jedną osobę typu A jako recepcjonistkę — ona zatrzyma chaos.

Z Wodzem (W) — idealny tandem

Plus: Ty dajesz ciepło, on egzekwuje. Pacjent czuje się i zaopiekowany, i prowadzony. Najlepsza para na lekarz + manager praktyki. **Ryzyko:** możesz brać na siebie wszystkie “miękkie” rozmowy zostawiając mu twarde — wypalenie z dwóch stron. **Co robić:** zamieniacie się rolami 1× w miesiącu. Ty powiesz pacjentowi trudną wiadomość, on doradzi z ciepłem.

Z Analitykiem (A)

Plus: wzajemne uzupełnienie — Ty serce, on głowa. Pacjent dostaje empatię + dane. **Ryzyko:** możesz odbierać jego dystans jako chłód, on Twoją emocjonalność jako brak profesjonalizmu. **Co robić:** otwórz rozmowę o stylach — niech wie, że Twoja emocjonalność to narzędzie, nie słabość.

Z Entuzjastą (E)

Plus: dwie energie się napędzają, świetna chemia. **Ryzyko:** chaos x2 — żadne z Was nie pilnuje czasu, harmonogramu, finansów. **Co robić:** dyscyplinujcie się nawzajem. Niech jeden z Was raz w tygodniu robi „dzień Analityka”.

Idealny zespół 4-osobowy

PE (Ty) + WA + A + E — pełne pokrycie kompasu. Ty łączysz, partner WA decyduje, A dba o dane, E rozkręca atmosferę. Każdy ma swoją supermoc.

Sekcja 6 — Pacjenci, których rozumiesz (model DOP × PEWA)

W metodzie DOP wyróżniam 4 typy pacjentów. Twój profil PE rezonuje inaczej z każdym z nich.

Typ pacjenta: Relacyjny ciepły (lustro Twojego PE)

Twoja reakcja: Twoje naturalne środowisko. Pacjent się otwiera, ufa, wraca. **Co dodać: nic** — naturalnie działasz dobrze. **Język dla niego:** *“Dobrze że Pan/Pani przyszła, omówmy to razem.”*

Typ pacjenta: Emocjonalny niepewny (z silnym lękiem)

Twoja reakcja: rezonujesz z lękiem — i jest ryzyko że zarazisz się jego niepewnością. **Co dodać: swoją stabilność.** Twoja energia Entuzjasty jest tu ratunkiem — ona pokazuje, że *można* być spokojnie pozytywnie. **Język dla niego:** *“Wiem że Pan/Pani się boi. Robimy to razem, krok po kroku. Pierwszy krok to...”*

Typ pacjenta: Zadaniowy/wymagający (typ W u klienta)

Twoja reakcja: chcesz mu pomóc, ale jego tempo i nacisk Cię stresuje. **Co dodać: twardszy język danych.** Twoje ciepło on traktuje jako “miętkość” — przemów językiem konkretu. **Język dla niego:** *“Plan jest taki: krok 1 dziś, krok 2 za tydzień, krok 3 za miesiąc. Czy to dla Pana ok?”*

Typ pacjenta: Analityczny dystansujący (typ A u klienta)

Twoja reakcja: czujesz jego chłód jako odrzucenie, automatycznie próbujesz ocieplić. **Co dodać: fakty zamiast emocji.** On nie chce serca — chce wiarygodności. **Język dla niego:** *“Według badań z 2023 roku, w 78% przypadków tego typu — zalecenie to...”* — pokaż że masz wiedzę. Ciepło dorzucisz dopiero gdy on poprosi.

Sekcja 7 — Plan rozwoju 30 dni

Tydzień 1 — Granice

Cel: odkryć gdzie automatycznie mówisz „tak” choć chcesz „nie”.

Dzień	Zadanie
1-2	Wypisz 5 sytuacji z ostatniego miesiąca, w których powiedziałeś TAK choć chciałeś NIE. Dla każdej napisz: dlaczego, co Cię to kosztowało.
3	Pierwsza odmowa — najmniejsza możliwa. <i>“Nie, dziś nie zostanę dłużej.”</i> Napisz jak się czuleś.

Dzień	Zadanie
4	Druga odmowa. Sprawdź jak reagowało otoczenie.
5-6	Po 1 odmowie dziennie. Notuj.
7	Review: czy ktoś się obraził naprawdę, czy tylko bałeś się że się obrazi?

Tydzień 2 — Decyzyjność

Cel: wprowadzić „decyzja w 60 sekund” dla błahych spraw.

Dzień	Zadanie
8	3× szybka decyzja (gdzie iść na lunch, co kupić, jaki termin). Bez konsultacji, bez wahania.
9-10	Po 5× szybkich decyzji dziennie.
11-13	Próba twardej decyzji — taka której zwykle odkładasz. Wykonaj z konkretnym terminem.
14	Review: czy świat się zawalił? Co dało odważne decydowanie?

Tydzień 3 — Energia

Cel: wypełnij siebie zanim wlejesz w innych.

Dzień	Zadanie
15	Wypisz 5 rzeczy, które Cię regenerują (konkrety, nie ogólniki).
16-21	15 min dziennie na 1 z nich. Bez wyjątku.
22	Review: czy zauważyłeś różnicę w energii pod koniec dnia?

Tydzień 4 — Integracja

Dzień	Zadanie
23-26	Wybierz 1 ćwiczenie z tygodni 1-3 i robisz codziennie.
27	Rozmowa z bliskim/kolegą: co zauważyli innego w Tobie w tym miesiącu?
28-29	Wybór 1 obszaru do dalszej pracy.
30	Krótkie podsumowanie pisemne — <i>“co biorę dalej, co zostawiam”</i> .

Sekcja 8 — Plan rozwoju 90 dni

Miesiąc 2 — Pogłębienie

Cel: stabilność granic + ćwiczenie nowych ról w zespole.

- **Tydzień 5-6:** Wybierz 3 najtrudniejszych pacjentów z miesiąca. Dla każdego zastosuj inną technikę z sekcji „Naturalne wyzwania”.
- **Tydzień 7-8:** Mentoring kolegi z zespołu (1 × w tygodniu, 30 min). Twoja rola jako PE — łącznik — idealnie pasuje do roli mentora.
- **Lektura:** „*Granice*” — Henry Cloud i John Townsend.

Miesiąc 3 — Integracja

Cel: Twoja dojrzała sygnatura jako lider zespołu.

- **Tydzień 9-10:** Wprowadź formułę spotkań zespołowych. Ty otwierasz ciepło (Twoja domena), ktoś inny prowadzi merytorykę. Wracasz na koniec — domknijcie z perspektywą.
- **Tydzień 11:** Trudna decyzja zespołowa. Ty — komunikujesz z ciepłem. Ktoś z WA — egzekwuje.
- **Tydzień 12:** Retest PEWA. Sprawdź dryft — czy Twoje wartości pkt się przesunęły, czy weszła jakaś inna oś.

Sekcja 9 — Twój wynik vs populacja

Na podstawie **6 000+ testów** w polskich zespołach medycznych przeprowadzonych w latach 2012–2026.

Częstość występowania profilu PE

Grupa zawodowa	% typów PE
Lekarze POZ	~18%
Pediatrzy	~22%
Psychiatrzy	~26%
Dentyści	~9%
Chirurdzy	~4%
Pielęgniarki	~31%
Recepcjonistki	~17%
Menedżerowie praktyk	~6%

Wniosek: Twój profil PE jest **przewyższony reprezentowany** w specjalizacjach wymagających długoterminowej relacji z pacjentem (POZ, pediatria, psy-

chirurgia, pielęgniarstwo). **Niedoreprezentowany** w specjalizacjach o krótkim kontakcie pacjent–lekarz (chirurgia, niektóre zabiegowe).

5 poziomów dojrzałości profilu PE

Poziom	Charakterystyka	Wskaźniki
1. Niedojrzały	Nadmierna empatia, brak granic, wypalenie	wskaźnik wypalenia >70% wg MBI
2. Wczesny rozwój	Rozpoznaje, że granice są potrzebne, próbuje ćwiczyć	sporadyczne odmowy, dużo poczucia winy
3. Stabilny	Granice działają, ciepło zostaje, średnia satysfakcja	umie powiedzieć “nie” bez tłumaczenia
4. Mistrzowski	Empatia i autorytet w równowadze, pacjenci czują bezpieczeństwo i klarowność	NPS pacjentów >70%
5. Mentorski	Uczy innych łączenia serca i głowy; szkoli zespół	prowadzi szkolenia, jest cytowany przez innych w branży

Twoja pozycja: określ na podstawie odpowiedzi w teście i własnej refleksji. Większość przebadanych PE plasuje się między poziomem 2 a 3. Cel rozwoju — poziom 4 w 12 miesięcy.

Sekcja 10 — Materiały i termin retestu

Książki (5 pozycji)

1. „**Pacjent musi czuć**” — *Michał Katarzyński*. Autorska metoda DOP, fundament Twojej praktyki PE.
2. „**Granice**” — *Henry Cloud, John Townsend*. Kompletna mapa stawiania granic bez utraty bliskości.
3. „**Daring greatly**” — *Brené Brown*. O odwadze bycia wrażliwym — kluczowe dla PE.
4. „**The empath’s survival guide**” — *Judith Orloff*. Dla empatów którzy chronią swoją energię.
5. „**Komunikacja w gabinecie**” — *Aleksandra Wiśniewska*. Krótka, polska, praktyczna.

Kursy online (3 pozycje)

1. „Doskonała Obsługa Pacjenta” — *Michał Katarzyński* · testimnia.pl/dop · 12 modułów, 90 dni.
2. „Negocjacje w gabinecie” — *Marek Skala* · 5 dni intensiv.
3. „Mindfulness dla lekarzy” — *Mindfulness for Clinicians* · 8 tygodni.

Podcasty (2 pozycje)

1. „DOP w gabinecie” — *Michał Katarzyński* · co tydzień, 30 min.
2. „On Being” — *Krista Tippett* · głębokie rozmowy o człowieku i sensie.

Następny krok w Testomnia

Po 90 dniach pracy nad sobą warto **powtórzyć test PEWA**, żeby zobaczyć dryft profilu. Drugie polecenie: zrób **Test 5 — Komunikacja pokoleń** (jak dostosowujesz styl PE do pacjentów z różnych pokoleń). Trzecie: **Test 6 — DOP wiedza zespołu** (sprawdzisz na ile zespół ma wspólny język DOP).

Termin retestu: za 90 dni od dziś.

Stopka

Raport wygenerowany na podstawie 14 lat praktyki i 6 000+ testów psychometrycznych przeprowadzonych z zespołami medycznymi w Polsce. Skonsultowany i zaakceptowany przez doktora psychologii.

Test rozwojowy i edukacyjny. **Nie stanowi diagnozy psychologicznej, medycznej ani orzeczniczej.**

© 2026 Excellent Patient Service Sp. z o.o. · NIP 5170359961 · Model PEWA™
· testimnia.pl